

开始,用两手从阴门两侧一点一点地向阴道内推送。子宫送入骨盆腔后,应将手臂尽量推送到腹腔内,使之展开复位。脱出的子宫全部被送入阴道后,术者应将手伸入子宫内,查证子宫角确实已进入腹腔,恢复正常位置,并无套叠;然后放入抗生素(青霉素 400 万单位、链霉素 400 万单位),并肌肉注射垂体后叶素 50 单位)。多数整复后可不再脱出,否则应在阴门周围做 2~3 个纽扣状缝合,但要留足尿道口。2~3 天后,如母牛不再努责,可拆线。

3.2. 药物治疗:

3.2.1. 西药:对子宫已经脱出的患牛,按常规用普鲁卡因或利多卡因 10ml 做荐椎或尾椎硬膜外麻醉后,用温水或 0.05%高锰酸钾水冲洗干净后整复。当母牛胎儿产出后(子宫内无胎儿),仍出现强烈努责等征候时或牛出现子宫部分脱出后,立即将子宫脱出部分送回,用 25%硫酸镁 150ml 配合 5%葡萄糖进行静脉注射

补液、强心、缩宫及止血可用 50%葡萄糖液 500 毫升及葡萄糖生理盐水 2000~3000 毫升另加 20%安钠咖 10 毫升 Vc5 克加温后静注;同时肌注垂体后叶素 50~100 单位。消炎抗菌可用青霉素 400 万单位与链霉素 5 克混合肌注。一般每日 1~2 次,连用 3~5 天。

3.2.2. 中药治疗:处方一:子宫脱手术整复后即投服中药补中益气汤。方用:全当归 100 克、陈皮 40 克、柴胡 25 克、蜜升麻 50 克、白术 50 克、党参 100 克、黄芪 100 克、益母草 50 克、高良姜 15 克、炙草 15 克,共煎汤灌服。子宫体水肿严重时加白芷、车前、茯苓皮。每日 1 剂,连服 2~5 剂。

处方二:黄芪 60 克、党参 30 克、甘草 12 克、陈皮 15 克、白术 30 克、当归 21 克、升麻 15 克、柴胡 30 克、生姜 12 克、熟地 9 克,大枣 3 个,饮用水煎服,每日一剂,连服三剂。

四、体会:

1. 应加管理。对孕牛特别是将临产的母牛应注意观察,做到及早发现,及时整复治疗。这样整复易,愈后好,否则发现迟,时间久,易感染,出血多,整复难,不利于子宫的复位及繁殖力的恢复。

2. 对习惯性子宫脱的母牛,应在产犊后立即投服中药补中益气汤,若脱出时间久,并有较大面积损伤或坏死时,应立即施行子宫切除或部分切除手术。但应尽量少用或不用切除手术,否则将影响繁殖能力甚至失去繁殖能力。

3. 术后 1~2 周内应加强对母牛的护理,给予少量易消化的优质全价饲料,同时注意母牛体温变化及恶露排出情况,及时对症治疗。用抗菌素全身治疗及投服补中益气汤,以促进母牛子宫体的复位及防止发生子宫炎症和全身感染。

猪腹泻病的中草药治疗试验

石远隆

(湖南省湘西州畜牧局, 416000)

摘 要:中草药组方:缬草、苦参、车前草、石榴皮、地枇杷等药水煎剂,用口服法治疗猪大肠杆菌病腹泻猪 29 头,治愈率 100%,疗效好,见效快,无副

作用,与对照组比较,经统计学测定, $P<0.01$,差异极显著。

关键词:中草药组方;猪腹泻病;疗效显著;

前言

猪大肠杆菌腹泻病,是一种古老的常见病。凡是养猪的地方,都能见到它的存在和危害。猪大肠杆菌病防治方面的研究层出不穷。然而,都未能从根本上解决问题,继续寻找更好的防治方法,成为一代又一代人们的目标。近年来一些新的抗生素和更好的化学合成药物不断地问世,为大肠杆菌病的防治提供了新的有力武器。然而,大肠杆菌并未困着,它们为了生存和发展,不断地改变自身的遗传密码,抗药菌株也就不断地产生。化学药物和抗生素的大量应用,会在畜禽体内组织细胞中形成残留,严重影响人的生命安全;大肠杆菌是人畜共患病,其抗药菌株的不断出现,严重威胁人畜的健康。中草药组方所含成分复杂,既有抑菌作用,又有增强畜禽自身抗病力的作用;中草药以有机物为主,经畜禽体内分解代谢,不形成化学物质残留,不影响人的健康。

经上所述,为本次中草药治疗猪大肠杆菌腹泻病实验研究的初衷。

1、 材料与方法

1、1 试验药物:缬草、苦参、石榴皮、车前草、地枇杷各 1000 克鲜药,先切粹,加水 5 公斤浸泡 1 小时,小火煎 30 分钟倒出药液,再加水 3 公斤,小火煎 30 分钟,倒出药液,两次药液合并备用。

1、2 试验猪:为某猪场 5 窝刚满双月断奶仔猪 50 头。全部经过“猪三联苗”和“口蹄疫苗”免疫。

1、3 试验分组:随机抽样每 10 头仔猪为一组,A、B、C 三组为试验组,D 组为感染大肠杆菌不用药治疗组,E 组为不感染不用药空白对照组。

1、4 致病性猪大肠杆菌,为湘西州防检站实验室提供。

1、5 疗效标准:用药后猪腹泻停止为有效,大便正常,吃食正常为治愈。

2、治疗试验

2、1 试验猪每组 10 头,分 A、B、C、D、E 5 个栏用同一种配合料饲养,预饲 10 天后开始试验。

2、2 试验猪 A、B、C、D 共 4 个组,每头猪用塑料注射器经口灌服“猪大肠杆菌培养液”1 毫升,E 组不感染大肠菌为空白对照。

试验猪感染大肠杆菌 18—48 小时后,A、B、C、D 4 个组的 39 头先后出现发病症状,吃食减少共 16 头,完全不吃 5 头,正常吃食 18 头;发病猪出现拉稀 29 头,其中严重水泻 10 头;C 组有一头试验猪全过程均不发病。

2、3 A、B、C 试验组的 29 头病猪,发病拉稀 6 小时后开始用上述中药水剂灌服治疗,每头用塑料注射器缓慢灌服 50 毫升,每天用药 2 次,隔 10 小时。

2、4 所有试验猪保证饮用卫生的自来水,饲养饲料同上,猪栏每天用 0.1%百毒灭水溶液喷雾消毒 2 次。

3、试验结果

3、1 A、B、C 三个试验组的 29 头猪,口服药 2 次能止泻者 6 头,口服 3 次止泻者 9

头，口服药 4 次止泻者 10 头，口服药 5 次止泻者 3 头，口服药 6 次止泻者 1 头。

3、2 A、B、C 三个试验组的 29 头猪，口服药 4 次恢复正常吃食者 4 头，口服药 5 次恢复正常吃食者 11 头，口服药 6 次恢复正常吃食者 8 头，停药后 48 小时才恢复正常吃食者 6 头，全程试验未发病 1 头。

3、3 D 组试验猪 10 头感染大肠菌，48 小时后全部发病，出现不吃食 2 头，吃食减少 6 头，正常吃食 1 头，发病第 4 天死亡 1 头，发病第 7 天自然止泻 1 头，第 15 天自然止泻并恢复正常吃食 6 头，第 19 天最后一头病猪才恢复正常。

3、4 E 组空白对照猪精神、食欲、大小便一直正常。
试验结果见表 1，表 2，表 3，

表 1 中草药治疗猪大肠杆菌腹泻病效果

效 组别	试 验 猪 (头)	治 愈 猪 (头)	治 愈 率 (%)	无效(头)	死亡(头)	死 亡 率 (%)	备注
A	10	10	100	0	0	0	阳性对照 空白对照
B	10	10	100	0	0	0	
C	10	9	90	0	0	0	
D	10	0	0	/	1	10	
E	10	/	/	/	0	0	

表 2 中草药治疗猪大肠杆菌腹泻病增重效果

体 重 组别	试 验 猪	试前体重 (kg)	试后体重 (kg)	体重增加 (kg)	备注
A	10	331.5	372	40.5	
B	10	310	335	25	
C	10	296	317	21	
D	10	342	278	-64	
E	10	374	448	74	

表 3 中草药治疗猪大肠杆菌腹泻病时间效果

组别\用药次	用药 1 次治 愈	用药 2 次 治愈	用药 3 次治 愈	用药 4 次治 愈	用药 5 次治 愈	用药 6 次治 愈
A	0	1	3	4	1	
B	0	3	2	3	1	1
C	0	2	4	3	1	
D	0	0	0	0	0	0
E						

4、结果与分析

4、1 本次试验用中草药共治疗大肠杆菌腹泻病猪 29 头，均全部治愈，有效率达 100%；治疗用药最少者 2 次，最多者 6 次，治愈时间最少者 2 天，最多者 5 天，疗效确切。

4、2 本次试验用的中草药缬草为败酱科植物，有清热解毒、抗菌消炎作用为主药；苦参为豆科植物，清热燥湿，车前草为车前草科植物，清热利尿，泄胃肠湿热共为辅；石榴皮为石榴科植物，涩肠止泻为佐；地枇杷为桑科植物，健脾胃调理胃肠功能，促进食欲为使。以上诸药共同构成了一个清胃肠湿热，涩肠止泻，调理脾胃功能的好药方，所以能够对猪大肠杆菌性腹泻有较好的治疗作用。

4、3 本次试验的 D 组为阳性对照组，不用药物治疗，虽经 17 天后耐过而自愈，但由于发病时间长，猪掉膘严重，生长发育受严重影响，另外还有一头猪因严重腹泻，脱水而死亡，经济损失比 3 个中草药治疗试验组大得多，试验组平均每头增重 2.1 公斤，对照组平均体重减少 6.4 公斤。经统计学测定 $P<0.01$ ，差异极显著。

4、4 本次试验每头猪用去中草药鲜品 170 克，折合干药 85 克，价值 1.6 元人民币。如果养殖户平时上山采药，晒干备用，则不要花钱，既经济又方便。

5、结论

- 5、1 中草药治疗猪大肠杆菌腹泻病 29 头，实验证明，治愈率达 100%，疗效确切。
- 5、2 本次实验药物组方合理，符合经济实用原则，值得进一步扩大推广。
- 5、3 中草药复方治疗猪大肠杆菌，比常用的化学药物不会在畜禽体内产生残留，不会影响人的身体健康。

5、4 现今引起畜禽疫病的许多菌株易对化学药物抗生素产生耐药性。中草药复方既能抑菌，又能增强畜禽抗病力，所以不易产生抗药菌株。

5、5 中草药必须煎药，还得逐头捉猪灌服，费时、费力，用药不便，因此新的剂型，新的投药方法值得进一步研究。

参考文献：

[1] 《中华兽药大典》，农业出版社，2005，
[2] 王自然，中药组方对猪大肠杆菌病的抑菌及临床治疗试验，中国兽医杂志，2006，42（2）33—34
[3] 田国宝，规模化猪场大肠杆菌耐药性和血清型变化趋势，中国兽医杂志，2007，43

(10) 31—33

[4] 施奉英, 猪大肠杆菌对 20 种抗生素的敏感试验, 中国兽医杂志, 2007, 43 (8) 8—10

[5] 张雪梅, 仔猪大肠杆菌的分离鉴定及中草药抑菌试验, 中国兽医杂志, 2006, 42 (1) 33—34

[6] 孙 键, 抗菌中草药作用机理的研究进展, 中国兽医杂志, 2007, 43 (2) 42—43

[7] 张庆茹, 中草药免疫促进作用的研究进展, 中兽医医药杂志, 1997, (5) 15—16

猫肝性脑病诊断与中西治疗策略

汪德刚¹ 王秀君¹ 吴昆泰²

(1 郑州牧业工程高等专科学校 2 中国台湾爱宝动物医院)

摘 要 猫肝性脑病是急慢性肝衰竭的最主要指标。猫肝脑病是急慢性肝脏疾病或门脉一体循环分流所引起的精神症候群。肝脏是动物体最重要的新陈代谢器官之一。它是动物体制造白蛋白(维持血浆渗透压)及其他血浆蛋白(如凝血因子)的唯一器官;它是维持血中葡萄糖恒定的重要器官;它是合成脂质及制造脂蛋白的最重要器官;它亦负责胆红素的代谢及各种内源性、外源性物质(如氨、类固醇、药物、毒物)的生物转换(biotransformation)。总括来说,肝脏是动物体制造、合成、代谢、解毒的大工厂。这些机能的丧失会引起多种临床表现并造成死亡。

关键词 猫 肝性脑病 中兽医

猫肝性脑病变(Feline Hepatic Encephalopathy, FHE)过去称肝性昏迷(Hepaticcoma),是严重肝病引起的、以代谢紊乱为基础的、中枢神经系统功能失调的综合病征,其主要临床表现是意识障碍或神经精神症状。本病在中兽医文献中,一般描述为“昏蒙”、“昏厥”、“昏愤”、“神昏”等。

1. 中兽医观病因与发病机理

中兽医无肝性脑病的名称,本病以神志昏乱,狂叫乱咬,或撮空理线、肢体震颤,巩膜黄染,舌红苔黄,脉弦滑为主要临床表现。中兽医认为本病多因外感湿热疫毒,内阻中焦,交蒸肝胆,肝失疏泄,胆汁外溢;湿热夹毒,郁而化火,热毒炽盛发为急黄;若热毒内陷心包则神昏谵语,撮空理线;热毒入营、迫血妄行则出血不止。如《沈氏遵生书》所言“又有天行疫病,以致发黄者,俗称之瘟黄(急黄)”。饮食不节,损伤脾胃,脾不健运,痰湿内生,升降失常,清者不升,浊者不降,大脑传导失司,浊气夹痰湿上犯出现肝臭,蒙蔽神明则谵妄、神志昏蒙、性格异常。黄疸、积聚等病日久迁延不愈,气血凝滞脉络瘀阻,痰瘀互结,水壅血瘀,渐成鼓胀,水积腹腔,精气不布,气化失司,清阳不升,浊阴不降,肝风内动,浊阴夹痰夹瘀上蒙心窍引起昏迷、扑动、震颤。总之本病为热毒炽盛,内陷心包,或气机升降失常,浊气夹痰夹瘀上蒙清窍所致之危机重症。病位在肝与脑,但与心密切相关。若治不及时每致“阴阳离决”而危及生命。

2. 现代兽医学观点

猫大部分肝性脑病是由各型肝硬化(肝炎后肝硬化最多见)引起,也可由改善门静脉高压的门体分流手术引起,如果连亚临床肝脑病变也计算在内,则肝硬化发生肝性脑病者明显增高。小部份脑病见于重症病毒性肝炎、中毒性肝炎和药物性肝病的急性期或爆发性肝功能衰竭阶段。更罕见的病因有原发性肝癌、妊娠期急性脂肪肝、严重胆道感染等。

猫肝性脑病变特别是门体分流性脑病常有明显的诱因,常见的有上消化道出血、大量排钾利尿、放腹水、高蛋白饮食、镇静药、麻醉药、便秘、尿毒症、外科手术、感染等。

猫肝性脑病的发病机制迄今尚未完全明了。一般以为产生肝性脑病的病理生理基础是肝细胞功能衰竭和门静脉之间因手术造成的或自然形成的侧支分流。主要是来自肠道的许多毒性代谢产物,未被肝解毒和消除,经侧支进入循环体,透过血脑屏障而至脑部,引起大